

Guía básica

Auditoría para la reacreditación
ante la Joint Commission
International

*Del 28 de octubre al 2 de
noviembre inclusive*



 **HOSPITAL ITALIANO**
de Buenos Aires

Departamento de Calidad

ÍNDICE

A) INTRODUCCIÓN	5
B) HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES	5
Organigrama institucional	5
Filosofía institucional	5
C) JOINT COMMISSION INTERNATIONAL	8
¿Qué es la acreditación?	8
¿Cómo se obtiene la acreditación?	8
¿Qué beneficios trae?	8
D) AUDITORÍA FINAL PARA LA ACREDITACIÓN	9
¿Cómo será esta auditoría?	9
<i>Tracers de Pacientes</i>	9
<i>Tracers de Historias Clínicas</i>	11
<i>Tracers de Sistemas</i>	11
<i>Tracers de Datos de Calidad</i>	11
¿Qué diferencia tiene la auditoría final de las visitas anteriores?	12

ÍNDICE (cont.)

E) RECOMENDACIONES PARA LA AUDITORÍA	14
¿Cómo preparase?	14
¿Cómo interactuar con un auditor?	15
Acciones a tener en cuenta	17
Mantenimiento de los depósitos	19
Control de temperatura de heladeras	19
Prevención de incendios	20
Plan de emergencia y evacuación	22
Uso seguro del láser	24
Prevención de riesgos biológicos	24
Código de vestimenta quirúrgico	25
Curso Integral de Seguridad Anual y Obligatorio	26
Código rosa	27
Código naranja	28
Código amarillo	29
Segundas Víctimas	30
Acompañar	31
Metas internacionales	32
Fatiga de alarmas	40
Evaluación de riesgo de suicidio	41

ÍNDICE (cont.)

Ciclos de mejora	42
Evaluación de la calidad percibida	44
Privacidad y confidencialidad de la información	46
Planificación de altas	49
Sitios de consulta rápida	49

ANEXO	50
--------------	-----------

Listado de normas/políticas más trascendentes para la re acreditación	50
---	----

A. INTRODUCCIÓN

Cumplidos los tres años de haber sido acreditados por tercera vez ante la **Joint Commission International (JCI)** llegó el momento de volver a ser evaluados. Esta auditoría ocurrirá este año, desde el 28 de octubre al 2 de noviembre incluido. Luego de la medición que hagan los auditores, el Hospital recibirá una nueva acreditación.

En esta oportunidad, la delegación estará conformada por cinco auditores, los cuales serán dos enfermeras, dos médicos y un especialista gestión y administración.

Esta guía tiene como finalidad repasar algunos conceptos clave, como también brindar recomendaciones e información acerca del proceso.

B. HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES

ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

Podrá descargar el organigrama institucional del Hospital Italiano ingresando a:
www.hospitalitaliano.org.ar

- Acerca del Hospital
 - o Autoridades
 - Dirección Médica
 - Dirección de Gestión

FILOSOFÍA INSTITUCIONAL

La filosofía institucional es la sumatoria de principios que guían al Hospital hacia el cumplimiento de sus metas y objetivos, y que facilita la labor del equipo directivo y del conjunto de personas implicadas en este gran proceso institucional.

Esencialmente la **misión** define ¿qué hacemos?, la **visión** ¿a dónde queremos llegar?, y los valores ¿cómo lo hacemos?

Misión

Somos un sistema integrado de salud, sin fines de lucro y con un hospital universitario de alta complejidad, comprometido con los problemas sanitarios de la comunidad, a la que procuramos brindar cuidados seguros y de alta calidad. Trabajamos para alcanzar el máximo nivel en la asistencia, la docencia de grado y posgrado, y la investigación básica, clínica y de la población.

Visión

Aspiramos a ser una institución de excelencia, líder en el sistema de salud de la Argentina e integrada a la comunidad científica internacional.

Valores

- **Idoneidad.** Trabajamos con el profesionalismo que nos otorgan años de trayectoria y conocimiento en cuidados para la salud.
- **Transparencia.** Compartimos información de manera clara y efectiva, respetando el derecho de todos los individuos a estar informados.
- **Confianza.** Creemos en las relaciones basadas en la confianza y brindamos un servicio de alta calidad médica.
- **Respeto.** Construimos relaciones basadas en el reconocimiento del otro y en el respeto a su identidad individual y dignidad humana.
- **Integridad.** Cuidamos la ética de cada una de nuestras acciones, que desarrollamos con rectitud y honestidad.
- **Compromiso.** Nos orientamos hacia la comunidad, decididos a generar valor social a través de la asistencia, la docencia y la investigación.

Posicionamiento estratégico integrado

NUESTRA MISIÓN

Trabajamos para brindar servicios de excelencia en el cuidado de la salud, la educación y la investigación, **centrados en las necesidades de las personas**.

QUE NOS PERMITEN CUMPLIR CON NUESTRA MISIÓN

5

EJECUTANDO LAS ESTRATEGIAS

4

OBTENIENDO RESULTADOS SUSTENTABLES

3

QUE CREA VALOR CENTRADO EN LAS PERSONAS

2

SOMOS MÁS QUE UN HOSPITAL

1

Acercar a las personas a nuestro universo

Generar valor a la población

REINVERSIÓN

CUIDADOS HUMANIZADOS

- CH1. Generación de servicios diferenciales.
- CH2. Expansión de los servicios ambulatorios.
- CH3. Expansión de los telecuidados.
- CH4. Medicina de precisión.
- CH5. Desarrollo de red derivadora.
- CH6. Cuidados basados en el valor.
- CH7. Impulso a las unidades de cuidados integrados.
- CH8. Desarrollo de una red de alianzas.

EDUCACIÓN

- ED1. Nuevas ofertas de grado y posgrado.
- ED2. Crecimiento de la educación virtual.
- ED3. Expansión de la oferta a Latinoamérica.
- ED4. Incremento de política de becas y accesibilidad.
- ED5. Ampliación de la extensión universitaria.
- ED6. Internacionalización de la universidad.

INVESTIGACIÓN

- IN1. Inserción universitaria de la investigación clínica.
- IN2. Categorización CONICET.
- IN3. Relación con instituciones públicas.
- IN4. Desarrollo investigación innovadora traslacional.
- IN5. Impulso en la búsqueda de *grants* e investigación patrocinada.
- IN6. Garantía de tiempo protegido para investigación.

INNOVACIÓN Y DESARROLLO

- ID1. Creación de una incubadora de emprendimientos (*Start Ups*).
- ID2. Comercialización de productos TIC.
- ID3. Desarrollo de patentes.
- ID4. Servicios de consultoría.
- ID5. Asesoría de organizaciones gubernamentales y ONG.
- ID6. Inteligencia artificial.
- ID7. Análisis de grandes volúmenes de información.

SUSTENTABILIDAD

AMBIENTAL

SOCIAL

ECONÓMICA

Crecimiento

Productividad
Aumento de ingresos/disminución de costos

PRESTACIONES
AL SERVIDOR

Antes del servicio

- Conocimiento del mercado
- Accesibilidad
- Imagen de marca

Durante el Servicio

- Servicios de alto valor
- Calidad y seguridad

Después del Servicio

- Experiencia superior
- Continuidad de cuidados

IMPULSO
AL SERVIDOR

ACTIVIDADES DE
SOPORTE

Cultura organizacional

Cuidados centrados en las personas / Liderazgo / Equipos transdisciplinarios / Pionerismo

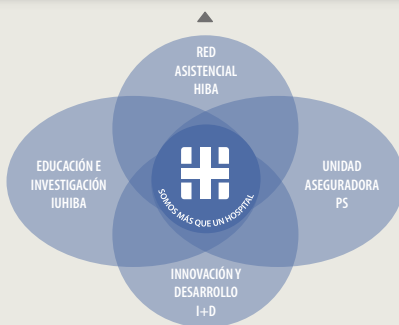
Estructura organizacional

Departamentos / Servicios / Gerencias

Recursos estratégicos

Tecnología de avanzada / Red edilicia / Talento humano / Sistemas de información

CREACIÓN DE VALOR



GENERAR RECURSOS PARA CUMPLIR NUESTRA MISIÓN

C. JOINT COMISSION INTERNATIONAL

¿QUÉ ES LA ACREDITACIÓN?

La acreditación ante la JCI es un proceso voluntario mediante el cual el Hospital será evaluado para determinar el cumplimiento de una serie de requisitos (estándares) destinados a mejorar la seguridad y la calidad de la atención. En esta oportunidad seremos evaluados nuevamente con la séptima edición del Manual de Estándares para la Acreditación Hospitalaria, en forma presencial.

¿CÓMO SE OBTIENE LA ACREDITACIÓN?

Se obtiene a partir del puntaje alcanzado en la evaluación del cumplimiento de más de 1.500 elementos medibles que abarcan aspectos asistenciales, de gestión y de gobierno. Éstos están publicados en el Manual de Estándares para la Acreditación Hospitalaria (Séptima Edición).

¿QUÉ BENEFICIOS TRAE?

La acreditación ante la JCI genera reconocimiento y prestigio a nivel institucional y a su vez, proporciona:

- Mayor confianza del público en lo referido al compromiso de la organización por la seguridad del paciente y la calidad de la atención.
- Un entorno laboral más seguro que contribuye con el bienestar del personal.
- La participación activa de los pacientes y sus familias en el proceso de atención.
- Una cultura abierta al aprendizaje bajo el concepto de la mejora continúa.

D. AUDITORÍA FINAL PARA LA ACREDITACIÓN

¿CÓMO SERÁ ESTA AUDITORÍA?

La auditoría actual tendrá una agenda similar a las anteriores visitas de la JCI. Los auditores revisarán la documentación y realizarán *tracers* (proceso utilizado por la JCI para evaluar la calidad y registro del cuidado de un paciente en particular; dentro de una organización de salud). Se evaluarán **tracers de Pacientes** (cerrados o abiertos), **tracers de Historias Clínicas**, **tracers de Sistemas**, y **de Datos de Calidad**.

Como en años anteriores habrá un equipo, conformado por colaboradores del hospital, acompañando a cada auditor por las instalaciones hospitalarias a fin de facilitar las recorridas.

Tracers de Pacientes

Un auditor seguirá el curso del cuidado, tratamiento y servicios provistos a un paciente por el Hospital, utilizando como punto de partida la Historia Clínica Electrónica (HCE).

Para seleccionar el paciente a evaluar, tendrá preferencia por aquel paciente que:

- Está relacionado con tracers de sistemas. Por ej.: un paciente con un tratamiento de quimioterapia, se relaciona con Farmacia o un paciente con una infección intrahospitalaria, se relaciona con el Programa de Control de Infecciones. (*Ver Tracers de Sistemas a continuación*).
- Atraviesa programas o ha sido atendido por diversos Servicios.
- Sigue un protocolo de investigación.
- Tenga un diagnóstico dentro de los cinco diagnósticos principales de egreso (cáncer y quimioterapia, recién nacido, reemplazo de articulación mayor e insuficiencia cardíaca).
- Fue atendido en áreas de internación psiquiátrica; unidades de diálisis, pediátricas o neonatales; obstetricia y/o rehabilitación (pacientes vulnerables, especiales o de alto riesgo).
- Proviene o será derivado de otra institución.

El auditor podrá optar por cualquier otro criterio que considere pertinente.

Adicionalmente, evaluará la interrelación entre las diferentes disciplinas, Departamentos, Programas, Servicios y Unidades que conforman el Hospital, y el desempeño de procesos relevantes, con énfasis en la integración, la coordinación interdisciplinaria y la identificación de potenciales riesgos o inconsistencias.

Su información será complementada con preguntas, recorridos o la solicitud de información adicional a todas las personas que integran el Hospital, incluido el personal tercerizado, estudiantes, residentes, pacientes o sus familiares.

A partir de sus observaciones evaluará:

- El ciclo de la medicación.
- La prevención de infecciones intrahospitalarias.
- Los procesos de cuidado interdisciplinario.
- La efectividad de comunicación dentro del Hospital y entre el Hospital y otras instituciones.
- El uso de los datos en el Sector/Servicio/Unidad/Hospital (mejora continua, análisis de datos, identificación de oportunidades de mejora, transmisión de la información, uso de la información para la mejora, etc).
- Aspectos relacionados con la seguridad.
- El rol del staff en la reducción de riesgos.
- El estado del equipamiento.
- El flujo de pacientes.
- La capacitación y el entrenamiento del personal.
- El proceso de toma del consentimiento informado.
- La calidad del registro en la Historia Clínica.
- El nivel de conocimiento y adherencia a los procedimientos, normas y políticas institucionales.

Tracers de Historias Clínicas

Pueden tomar los siguientes criterios:

- Pacientes próximos al alta.
- Pacientes con similar diagnóstico pero diferentes equipos tratantes.
- Iguales exámenes complementarios en diferentes ubicaciones.
- Pacientes con estadía prolongada.

Si en las recorridas o tracers encontraron algún desvío, lo buscarán. Por ejemplo, si faltaba algún consentimiento informado, había inconsistencias de la información o la Histórica Clínica Electrónica estaba incompleta, buscarán la HCE correspondiente. Tratarán de ver si los desvíos fueron excepcionales o se repiten.

Tracers de Sistemas

Es un período durante la auditoría dedicado a evaluar asuntos de seguridad de alta prioridad y la calidad del cuidado, en una base que abarque todo el sistema de la organización.

Los aspectos a relevar serán:

- Desempeño del proceso clave en cada sector; con énfasis en la integración y la coordinación de los mismos.
- La comunicación cruzada entre Departamentos y Servicios.
- Potenciales riesgos. Por ej: ciclo de la medicación, programa de control de infecciones, instalaciones, quirófanos, central de esterilización, salas de endoscopia, entre otros.

Tracer de Datos de Calidad

Pacientes, Servicios y Departamentos

Aquí se combinan los tracers de Pacientes y la sesión de Calidad.

Se espera que cada auditor visite virtualmente las áreas de internación y le pregunte a los grupos tratantes acerca de las acciones que toman de acuerdo a sus resultados/indicadores. Van a indagar acerca de qué se conoce sobre datos de calidad del Hospital en general y de los Servicios y Departamentos en particular:

Cinco diagnósticos principales de egreso

(Ordenados por frecuencia)

- Cáncer y quimioterapia
- Parto y cesárea
- Recién nacido
- Colectomía
- Reemplazo de articulación mayor

Áreas Priorizadas por el Hospital:

- Metas Internacionales
- Prevención y Control de Infecciones
- Registros Asistenciales
- Gestión y Uso de Medicamentos
- Evaluaciones Profesionales

¿QUÉ DIFERENCIA TIENE LA AUDITORÍA DE LAS VISITAS ANTERIORES?

	AUDITORÍA 2021	AUDITORÍA 2024
Objetivo	Otorgar o denegar la reacreditación. Buscarán nuestras debilidades.	Otorgar o denegar la reacreditación. Buscarán nuestras debilidades.
Quiénes evalúan	Auditores	Auditores
Estilo de comunicación	Formal. No hay docencia: sólo se evalúan los resultados. El auditor tomará nota, hará preguntas y probablemente pocos comentarios. Por favor; solo responder la pregunta, y no extenderse en comentarios: las respuestas breves y concretas facilitan la comunicación.	Formal. No hay docencia: sólo se evalúan los resultados. El auditor tomará nota, hará preguntas y probablemente pocos comentarios. Por favor; solo responder la pregunta, y no extenderse en comentarios: las respuestas breves y concretas facilitan la comunicación.

	AUDITORÍA 2021	AUDITORÍA 2024
Formato	Virtual: cinco auditores que se encontraban en su lugar de origen (USA, Brasil, India, etc.). Se utilizaron distintos dispositivos electrónicos (celulares, PC, notebooks) para conectarnos a la plataforma Zoom, elegida por la JCI. A través de la misma, se realizarán las sesiones cerradas y los diferentes tipos de tracers.	Presencial: cinco auditores recorriendo todas las instalaciones de la Institución.
Idioma	Hablar en castellano. No nos está permitido hablar en inglés en esta oportunidad.	Hablar en castellano. No nos está permitido hablar en inglés en esta oportunidad.
Consecuencias de los hallazgos	Brindan un puntaje del que se desprende si aprobamos o no. Es necesario aprobar TODOS los capítulos. Para aprobar un capítulo hay que tener al menos un 80% de los estándares aprobados. En el caso de las Metas Internacionales, los elementos medibles deben ser aprobados en su totalidad.	Brindan un puntaje del que se desprende si aprobamos o no. Es necesario aprobar TODOS los capítulos. Para aprobar un capítulo hay que tener al menos un 80% de los estándares aprobados. En el caso de las Metas Internacionales, los elementos medibles deben ser aprobados en su totalidad.
Agenda	Diseñada por el jefe del equipo	Diseñada por el jefe del equipo
Versión del manual	7ma. edición	7ma. edición
Quiénes participan	Sólo los requeridos.	Sólo los requeridos, pero VOS podés ser uno de ellos

E. RECOMENDACIONES PARA LA AUDITORÍA

¿CÓMO PREPARARSE?

Es muy importante conocer los documentos institucionales. Nuestras Normas/ Políticas vigentes están publicadas el sitio de Normas y Procedimientos (intranet). Estos documentos son el punto de partida de los auditores para conocer nuestros procesos. Es de suma importancia familiarizarse con su búsqueda, lectura y contenidos.

Al final de esta guía (ver página 50) encontrará un breve resumen de las políticas principales para el grupo asistencial. Es fundamental estar familiarizados con los estándares y las metas internacionales.

Recomendamos la realización de una reunión con **todo el equipo de trabajo** por lo menos **cuatro semanas antes** de la fecha de la auditoría. Es muy importante que este encuentro sea multidisciplinario y reúna diferentes jerarquías para solucionar temas o aclarar dudas.

En caso de tener interfases con otros grupos de trabajo, también recomendamos la realización de una reunión para evaluarlas. Los auditores revisarán su funcionamiento ya que frecuentemente en estas instancias se puede perder información y generarse inconsistencias.

Si considera necesaria la presencia de alguno de los miembros del equipo del Departamento de Calidad en las reuniones, estamos a su disposición.

¡RECORDAR!

El Hospital tiene 4 niveles de gobierno:

- El Consejo Directivo
- El Comité Operativo
- Las Direcciones
- Los Departamentos y Gerencias

TODOS | ¿CÓMO INTERACTUAR CON UN AUDITOR?

El auditor es una persona que nos evalúa en poco tiempo.

Las siguientes recomendaciones pueden contribuir a establecer un mejor vínculo de trabajo, facilitarles su tarea y mejorar nuestro desempeño:

- Una sola persona del grupo será seleccionada por el auditor para responder: **Por favor, evitar interrumpir a quien responda.** Si se encuentra ocupado cuando el auditor le realiza una pregunta, solicitar un momento para poder indicar a alguno de sus compañeros el reemplazo. Esta acción será valorada por el auditor.
- **Apagar o silenciar el celular.** Si está en modo silencio y su función lo obliga a responder (se encuentra de guardia), solicitar permiso al auditor para contestar la llamada.
- El ámbito de la auditoría es **formal**. Sugerimos tratar al auditor amablemente y evitar las bromas.
- **Hablar pausadamente** para favorecer la comunicación y ser firme en sus respuestas.
- **Responder únicamente a la pregunta realizada**, en forma breve y concreta.
- Si no se comprende la pregunta, **solicite que se repita o reformule.**
- Si no se conoce o recuerda la respuesta, **indicar dónde encontrarla** o a quién dirigirse.
- **Evitar discutir**, excusarse o tener una actitud defensiva frente al auditor.
- Hablar en castellano. No nos está permitido hablar en inglés en esta oportunidad.
- **Ser prudente** con los comentarios realizados. Es muy probable que entiendan el castellano aunque no lo manifiesten.
- Despedirse amigablemente del auditor.

¿Cómo sentirse más confiado a la hora de responder?

- **Conocer los indicadores** más importantes del sector. Saber por qué fueron seleccionados. Centrarse en el objetivo de mejorar un proceso y no en la construcción matemática del indicador. Los auditores quieren saber que temas nos preocupan y cómo abordamos soluciones.
- **Conocer el desempeño** del sector. Solicitar al responsable del área que comparta los indicadores institucionales y locales. Discutir qué acciones se pueden proponer para mejorar el desempeño, las barreras que identifican, los objetivos del área en términos de seguridad del paciente y calidad a corto, mediano y largo plazo.
- **Conocer los proyectos** del sector relacionados con calidad y seguridad. Solicitar al responsable del área que los comparta con todos.
- **Conocer los cambios** que se han hecho en su sector para mejorar la seguridad. Por ej.: implementación del check list operatorio, campaña de lavado de manos, cambios en el ciclo de la medicación.

Revise las **Proformas de Ciclos de Mejora** instaladas en su área, verifique que se ajusten a las cinco áreas priorizadas del Hospital (*Metas Internacionales, Prevención y Control de Infecciones, Registros Asistenciales, Gestión y Uso de Medicamentos y Evaluaciones Profesionales*) y que su seguimiento y control se realicen en tiempo y forma.

- **Conocer las políticas institucionales.** Podrá encontrarlas en el área de Normas y Procedimientos en la Intranet.
- **Informar a su jefe o supervisor** cualquier situación en la que el auditor tenga una apreciación negativa. Esto es **muy importante** ya que tenemos pocas oportunidades para revertir una situación adversa: necesitamos saberlo rápido. No se sienta responsable si le fue mal, le solicitamos **avisar de inmediato al Departamento de Calidad (interno 9947)**.

¿Qué hacer si un auditor nos solicita una acción fuera de lo habitual?

Los auditores esperan que usted cumpla con sus tareas de forma habitual siguiendo los procedimientos establecidos. Si le solicita que realice alguna acción fuera de lo permitido por la institución, negarse con cortesía y firmeza.

¡RECORDAR!

Portar **siempre** la **credencial identificatoria** en un lugar visible.

ACCIONES A TENER EN CUENTA*

**Representan la mayor frecuencia de deficiencias en los Hospitales que son evaluados por la JCI*

ACCIÓN	RESPONSABLE	QUÉ HACER SI HAY UN PROBLEMA
Los pacientes tienen la pulsera identificatoria cuando corresponde (internación y episodios ambulatorios).	Enfermeros, Admisión, administrativos y médicos.	Solicitar la corrección o reimpresión a través del sistema ADT.
Los pacientes son identificados correctamente (nombre y apellido, fecha de nacimiento).	Todo el equipo interviniente. Revisar algoritmo política 68/I 3.	Si alguien del equipo detecta la falla deberá recordar a su compañero la necesidad de ésta acción.
Los pacientes saben en qué Servicio están internados, quiénes son sus médicos, cuál es su plan de cuidados (tratamientos o estudios) y cuál es su plan de alta. Él y su familia tomaron parte en las decisiones. Fueron educados.	Médicos y enfermeros y resto del equipo de salud.	Recomendamos que los coordinadores de grupos o las personas que los jefes de Servicio dispongan, supervisen que esto ocurra. Muestreo o auditoría a todos los pacientes comenzando un mes antes de la visita para reforzar conducta.
Documentación en la HCE acorde a los estándares, recomendaciones del Comité de Historias Clínicas, Políticas Institucionales y capacitación en el uso de la HCE.	Médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud que evolucionan.	Recomendamos que los coordinadores de grupos o las personas que los jefes de Servicio dispongan, supervisen que esto ocurra. Muestreo o revisión de todas las HCE comenzando un mes antes de la auditoría para reforzar conducta.
Cartelería correspondiente a aislamientos o precauciones especiales si corresponde, en la puerta de la habitación.	Enfermeros y Comité de Control de Infecciones.	Los supervisores de piso deben revisar diariamente.
Consentimientos informados que correspondan, disponibles y completos.	Médicos y personal que toma consentimientos informados.	Recomendamos que los coordinadores de grupos o las personas que los jefes de Servicio dispongan, supervisen que esto ocurra. Muestreo o revisión de todas las HCE comenzando un mes antes de la auditoría para reforzar conducta.

RECOMENDACIONES PARA LA AUDITORÍA

ACCIÓN	RESPONSABLE	QUÉ HACER SI HAY UN PROBLEMA
Detección, valoración, tratamiento y reevaluaciones del dolor en pacientes ambulatorios e internados (ver Política 19/13 y Guía de Práctica Clínica: Manejo del dolor para pacientes internados).	Médicos y enfermeros.	Recomendamos que los coordinadores de grupos o las personas que los jefes de Servicio dispongan, supervisen que esto ocurra. Muestreo o revisión de todas las HCE comenzando un mes antes de la auditoría para reforzar conducta.
Valoración del dolor en pacientes ambulatorios.	Médico tratante, enfermero, kinesiólogo, odontólogo.	Recomendamos que los coordinadores de grupos o las personas que los jefes de Servicio dispongan, supervisen que esto ocurra. Muestreo o revisión de todas las HCE comenzando un mes antes del inicio de la auditoría para reforzar conducta.
En los pacientes con sujeciones recuerde: realizar la indicación médica de la sujeción (médico) y documentar las evaluaciones según la política de sujeciones (enfermero).	Médicos y enfermeros.	Recomendamos que los coordinadores de grupos o las personas que los jefes de Servicio dispongan, supervisen que esto ocurra. Muestreo o revisión de todas las HCE comenzando un mes antes del inicio de la auditoría para reforzar conducta.
En los pacientes con Riesgo de Suicidio recordá completar la escala SADPERSONS.	Médico tratante.	Recomendamos que los coordinadores de grupos o las personas que los jefes dispongan, supervisen que esto ocurra.
Evaluaciones de caídas, dolor, riesgo psicológico, evaluación funcional, social y screening nutricional realizadas y documentadas.	Enfermeros, médicos y nutricionistas	Recomendamos que los coordinadores de grupos o las personas que los jefes de Servicio dispongan, supervisen que esto ocurra. Muestreo o revisión de todas las HCE comenzando un mes antes de la auditoría para reforzar conducta.
Salidas de emergencia sin obstrucciones.	Depto. de Seguridad e Higiene.	Si se detectan salidas de emergencia obstruidas, avisar al interno 8855 / 8929.
Matafuegos	Depto. de Seguridad e Higiene.	Revisión del buen estado y vencimientos de los matafuegos y la no obstaculización del acceso a los mismos. Si detecta un desvío, avisar al interno 4482 / 8929.
Carros de paro	Supervisor de enfermería y Farmacia revisan acorde a la lista y política.	Solicitar ayuda a la Gerencia de Ingeniería Clínica por desperfectos técnicos (Int. 8274) y reponer medicamentos según el Procedimiento.
Almacenamiento de medicamentos.	Servicio de Farmacia o enfermería según corresponda.	Adecuar los espacios de guardado de acuerdo a las Políticas Institucionales.
Higiene de manos	Todos	Higienizar las manos antes y después del contacto con un paciente respetando los cinco momentos definidos por la OMS.
Descartadores de cortopunzantes fijados.	Depto. de Seguridad e Higiene.	Si se detecta que un descartador no está fijado, avisar al interno 4482 / 8929.
Segregación de residuos	Todos	Realizar la segregación de residuos respetando las Normas y Políticas Institucionales.

MANTENIMIENTO DE LOS DEPÓSITOS

- Recordar mantener el stock mínimo y necesario, el orden y las puertas cerradas e identificadas.
- Asegurar que los elementos almacenados estén a una distancia razonable del piso, el cielo raso y los artefactos de luz.
- Comprobar que no haya incompatibilidades. Por ej.: material estéril y ropa sucia o sustancias ácidas junto a alcalinas.
- Si se poseen sustancias peligrosas e inflamables, respete el listado y cantidad de sustancias permitidas. Ante cualquier duda consulte con Seguridad e Higiene.

CONTROL DE TEMPERATURA DE HELADERAS

El rango de temperatura para medicamentos debe estar entre 2 y 8°C. La temperatura de las heladeras para guardar alimentos no deben superar los 5°C.

- Controlar mínimamente una vez por turno respetando el Procedimiento institucional (I28/I5).
- Registrar la cifra por escrito en el formulario de control correspondiente.
- Ante un desvío del rango de temperatura, registrar la acción realizada en la planilla correspondiente. El Depto. de Enfermería y el servicio de Alimentación tienen procedimientos escritos. Por favor, conocerlos y tenerlos disponibles cerca de las heladeras.
- De persistir el desvío, informar de inmediato a un Supervisor o Coordinador de Enfermería, el cual solicitará la reparación al Depto. de Mantenimiento. Preservar el contenido direccionándolo hacia otra heladera.

Prevención de incendios

Interno para
Emergencias
8700



Para prevenir incendios

Es importante respetar las siguientes indicaciones:

- Mantener el orden y la limpieza de las instalaciones
- Utilizar correctamente los equipos; por ejemplo, apagar la computadora al terminar la jornada laboral
- Evitar la acumulación de materiales inflamables
- Desconectar los equipos eléctricos como, por ejemplo, cafeteras, estufas, equipos de audio, transformadores y cargadores de celulares al retirarse del puesto de trabajo
- Solicitar una instalación segura, si se requieren más enchufes en el sector



En caso de incendio

Seguir estas recomendaciones nos permitirá reducir los riesgos de accidentes y controlar el fuego lo más rápido posible:

1. Llamar de inmediato al interno 8700
2. Intentar extinguir el fuego cuando éste recién se inicia.
Es importante que no lo intente si desconoce cómo hacerlo
3. Permitir actuar a la Brigada de Emergencia
4. Abandonar el lugar en forma ordenada, evitando el pánico



Sobre el uso de extintores portátiles

Ante una situación de incendio, el uso del matafuego puede limitar sus consecuencias. A continuación, detallamos las distintas clases de fuego y los extintores que deben usarse en cada caso.

A

Fuego clase A: COMBUSTIBLES SÓLIDOS como madera, papel, telas, gomas, plásticos, etc.

B

Fuego clase B: COMBUSTIBLES LÍQUIDOS como naftas, aceites, solventes, grasas, pinturas, etc.

C

Fuego clase C: de ORIGEN ELÉCTRICO, se desarrollan en equipos e instalaciones sometidas a la acción de la corriente eléctrica.

Nunca combatir el fuego cuando:

- Éste se está esparciendo
- No tiene el equipo adecuado
- No es posible controlarlo y pelagra su acceso a la salida

Para contactarse con la oficina de bomberos por dudas o inquietudes, llamar al **interno 4142/8929**



En caso de evacuación

Mantener la calma y seguir los pasos que se detallan a continuación:

- Ubicar al Responsable de Piso (chaleco naranja)
- Formar un grupo con todas las personas que estén en el lugar
- Dirigirse a la salida de emergencia
- Nunca volver al lugar ni permitir que otros lo hagan
- Avisar si falta alguna persona
- Verificar que la puerta no esté caliente o el sector de salida no esté lleno de humo; si es así, buscar una ruta alternativa
- Cubrirse la boca y la nariz con un pañuelo o paño húmedo si hay humo. En ese caso, es preferible desplazarse agachado, ya que el aire más puro y fresco se encuentra más cerca del piso
- Nunca utilizar el ascensor
- Bajar por escalera, en fila india, sobre la mano derecha y ayudar a quienes no pueden bajar por sus propios medios



Servicio de Prevención de Incendios del Hospital Italiano

Cuenta con una dotación de cuatro Bomberos, que cubren guardias las 24 horas, los 365 días del año. Tiene por finalidad evitar que se ponga en riesgo la integridad de las personas y los bienes del Hospital, y actuar en caso de emergencia.

Además, colabora con ellos una Brigada de Emergencia, formada por personal de distintos sectores de la institución.

Las principales tareas del Servicio de Prevención de Incendios son:

- Coordinar actividades con la Brigada de Emergencia
- Gestionar el control y el mantenimiento de las instalaciones fijas contra incendios y equipos manuales de extinción
- Emitir permisos de trabajo de riesgo, como soldaduras, amolados, etc.
- Brindar capacitación
- Realizar recorridos periódicos, de manera preventiva
- Cubrir las necesidades de los Centros Médicos
- Colaborar con el Dpto. de Mantenimiento ante cortes de energía, inundaciones o fallas en los ascensores cuando hay personas adentro.

PLAN DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN

- » EVACUACIÓN DE LAS PERSONAS
- » USO DE EXTINTORES
- » SISTEMA DE ALARMAS

EL RESPONSABLE DE PISO es el nombre con el que se designa a la **persona que organiza y lleva a cabo la evacuación de un sector o lugar.**

Tendrá a su cargo el correcto desarrollo de las tareas de evacuación hacia el punto de reunión del personal, las visitas y los pacientes ambulatorios. En caso de pacientes inmovilizados y de alta complejidad, actuará en coordinación con el Jefe Médico del Servicio, Piso o Sector que se debe evacuar.

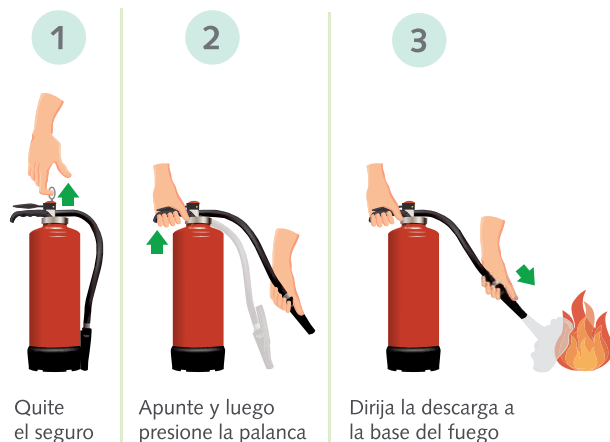
Deberá identificarse con el **chaleco color naranja** que se encuentra a disposición en su sector.

TAREAS DEL RESPONSABLE DE PISO

El responsable de piso tiene las siguientes tareas:

- » Realizar una evaluación de la magnitud del incidente.
- » Iniciar los procedimientos para velar por la seguridad del personal, las visitas y los pacientes.
- » Asumir la responsabilidad de las primeras medidas organizativas respecto a la evacuación.
- » Concentrar al personal que no interviene del plan de evacuación en puntos seguros.
- » Revisar cada lugar del sector a su cargo, a fin de asegurar la ausencia de personas (baños, salas, oficinas, office, etc.).
- » Regular la velocidad de avance de la columna y dirigirla para que no se produzcan atascamientos en los pasillos y escaleras.
- » Una vez en el punto de reunión, realizar el conteo del personal a su cargo.
- » Coordinar con el Grupo Operativo Médico y Dirección Médica, la operativa a seguir con pacientes inmovilizados del o los sectores afectados.

Correcta utilización del extintor de fuego:



El **Plan de Emergencias** establece las secuencias de acciones a seguir, para el control inicial de la emergencia y la conducta de los intervinientes y ocupantes.

DEFINICIONES IMPORTANTES

Dentro del Plan de Emergencia y Evacuación hay ciertas definiciones que son importantes conocer:

Grupo de Control de Incendio y Siniestros: Son los encargados del control de las emergencias que tengan que ver con el ámbito bomberil. Está constituido por el Bombero de turno y la Brigada de emergencia.

Evacuación: Acción de desalojar o desocupar en forma ordenada un lugar. Esta acción es realizada por razones de seguridad, ante un peligro potencial o inminente para sus ocupantes.

Vías de evacuación: Medio de salida exigido que constituye una línea natural de tránsito que garantiza una evacuación rápida y segura.

Punto de Reunión: Lugar de encuentro temporal que cumple la característica de ofrecer seguridad a las personas que allí deben concurrir.

RECUERDE: ante cualquier evento de emergencia **siempre** se debe activar la alarma llamando al **8700**. De esta forma se accionan los mecanismos de mitigación dispuestos.

Las rutas de evacuación siempre deben estar despejadas, nunca bloquee las salidas de emergencia.

USO SEGURO DEL LÁSER

- Se desarrolló un programa para el uso seguro de los equipos de láser y otras radiaciones no ionizantes.
- Se controlan los equipos de láser y otras radiaciones no ionizantes, al igual que los ambientes en los cuales se utilizan.
- Se informa que los equipos de láser y otras radiaciones no ionizantes están siendo usadas en los diferentes ámbitos de aplicación .
- Se capacita al personal que hará uso de los láseres y otros equipos de radiación no ionizante.

PREVENCIÓN DE RIESGOS BIOLÓGICOS

- No encapuchar agujas ya utilizadas para evitar pincharse.
- Descartar las agujas utilizadas en los contenedores destinados a tal fin.
- Nunca dejar elementos cortopunzantes en las camas, mesadas de las habitaciones u Offices de enfermería.
- Evitar llenar los descartadores y las bolsas rojas por encima de 2/3 partes de su capacidad.
- Usar los anteojos de seguridad, cuando la maniobra a realizar implique una potencial salpicadura.
- Respetar los procedimientos de trabajo establecidos.
- Utilizar siempre los elementos dispuestos para protección personal.

CÓDIGO DE VESTIMENTA ADECUADO

Centro de las áreas restringidas y semi-restringidas.



Ambo quirúrgico.



Orejas sin aros colgantes. en caso de utilizar aros, deberán estar contenidos por el gorro.



Manos y muñecas sin anillos, relojes y/o pulseras.



Uñas cortas y sin esmalte (tampoco semipermanente).
No se permiten uñas esculpidas.



No estás permitidos piercings que queden al descubierto, fuera del gorro o barbijo, como por ejemplo en las cejas.



Utilizar calzado protegido con botas descartables. En caso de usar zapatillas o cualquier otro calzado, siempre debe estar cubierto por las botas descartables



Usar sólo en áreas restringidas (Quirófanos):
barbijo triple capa descartable que cubra nariz y boca.

El equipo deberá además sumar la vestimenta estéril adecuada:

• CAMISOLÍN

• GUANTES

Para mas información recuerda hacer...

MODALIDAD VIRTUAL

Obligatorio para
todo nuestro
personal

CURSO INTEGRAL **DE SEGURIDAD ANUAL Y OBLIGATORIO**

¡Construyamos una cultura de seguridad que
refleje nuestra filosofía y visión!



Hospital Central y Anexos

CÓDIGO ROSA

Pérdida o secuestro de niños

Llamá al

8700

¿Cómo actuar?

- 1. Llamar al 8700** y **notificar** al supervisor de Enfermería del sector y/o a la coordinación a los internos 9494, 8434, 9266 y/o radios *230022 y *230944.
 - 2. Informar a todas las personas que trabajan en el sector diciendo “Hay un Código Rosa en proceso”.** Esto puede transmitirse boca en boca, por altoparlante o utilizando los intercomunicadores.
 - 3. Bloquear la salida** de toda persona del sector hasta que se identifique y registre a la misma.
 - 4. Limitar el acceso** al área únicamente a personal policial, seguridad y personal autorizado por Protección Hospitalaria.
 - 5. Chequear** que el niño no haya sido llevado a otro servicio o sector, consultorio o habitación por causas médicas o de rutina.
 - 6. Realizar una búsqueda** exhaustiva por todo el sector y zonas aledañas en forma profunda y rápida.
- » **En caso de confirmarse la pérdida, compilar toda la información referente al niño, incluida fotos si las hubiese.**

Apoyo y contención a los familiares del niño

Es importante **brindar apoyo y contención a los familiares del niño**. Si es posible, llevarlos a una habitación o lugar privado, fuera del área afectada:

» **Tranquilizarlos e informarles que se está siguiendo un protocolo para encontrar al menor.**

» Evitar preguntas que puedan hacerlos sentir culpable, como por ejemplo “¿Ustedes dónde

estaban?”

» Ponerse a su disposición (Por ejemplo, preguntarle si quiere llamar a alguien).

» **En caso de considerarlo necesario, el médico del sector puede solicitar apoyo a la Guardia Psiquiátrica de Adultos radio *230055**

Si se detectara algo sospechoso durante la búsqueda, volver a llamar al 8700 o avisar al personal de seguridad más cercano.



CÓDIGO NARANJA

Niños solos o perdidos
dentro del Hospital

Llamá al

8700

¿Cómo actuar?

- 1. Llamar al 8700.**
- 2. Acercarse al niño** con la precaución de no alarmarlo, ya que puede no ser consciente de que lo están buscando y puede asustarse y escapar. Presentarse con su nombre y preguntarle al niño el suyo.
- 3. Tratar de calmar al niño**, diciéndole que usted está allí para ayudarlo y que más ayuda vendrá en camino.
- 4. Mantenerse siempre cerca del niño** en un lugar concurrido y de ser posible, dentro de la visión de las cámaras de vigilancia del Hospital.
- 5. Trasladar al niño a la Guardia Pediátrica**, si se encuentra en el edificio Central, o en la sala de Enfermería, en el Anexo Potosí. **El niño siempre debe estar acompañado por personal de Enfermería y Seguridad.**
- 6. Consultar al niño**, si es posible, si acordó con sus papás un lugar de encuentro en caso de perderse o si recuerda un número de teléfono.
- 7. Aguardar el arribo del encargado** de turno de seguridad o de la supervisión de Enfermería, quienes seguirán el protocolo indicado para resolver la situación.

En caso de detectar una persona con capacidades diferentes o ancianos desorientados dentro del Hospital, se realizará el mismo procedimiento (a excepción del punto 5).

Departamento de Protección
Hospitalaria



Hospital Central y Anexos

CÓDIGO AMARILLO

Fuga de pacientes

Por intención de huída o desorientación

Llamá al

8700

¿Cómo actuar?

- 1. Llamar al 8700** y **notificar** al supervisor de Enfermería del sector y/o a la coordinación a los internos 9494, 8434, 9266 y/o radios *230022 y *230944.
- 2. Chequear** que el paciente no haya sido llevado a otro servicio o sector, consultorio o habitación por causas médicas o de rutina.
- 3. Realizar una búsqueda rápida** por todo el sector y zonas aledañas.
- 4. Ponerse a disposición** del personal de seguridad y Protección Hospitalaria.

¿Cómo actuar en caso de encontrar un paciente deambulando solo por pasillos o accesos al Hospital?

- 1. Llamar al 8700.**
- 2. Acercarse** con la precaución de no alarmarlo, ya que puede no ser consciente de que lo están buscando.
- 3. Aguardar junto al paciente** la llegada de ayuda, de ser posible, dentro de la visión de las cámaras de vigilancia del Hospital.

Pautas para detectar un paciente que puede haberse fugado:



Está vestido con ropa de cama.



Utiliza ojotas, pantuflas o está descalzo.



Se encuentra desorientado.

Segundas víctimas

¿Quiénes son?

¿Qué situaciones las desencadenan?

¿Qué podemos hacer en estos casos?



Cuando todo sale bien, los pacientes que atendemos vuelven a su casa mejor que cuando vinieron. Los tratamientos que indicamos impactan positivamente en su salud. Los cuidados que brindamos mejoran su estado de ánimo y aceleran su recuperación. Con todo esto, nuestra autoestima se eleva y nos sentimos verdaderamente bien.

Ahora ¿qué pasa cuando algo no sale como esperábamos? ¿Cómo nos sentimos ante la muerte de un paciente cuando nos toma por sorpresa? ¿Cómo reaccionamos frente a nuestro error que tuvo un impacto negativo? ¿Con quién hablamos cuando alguna de estas situaciones nos afecta personalmente? En el Hospital todas estas cosas nos suceden y cuando una persona se siente afectada es una segunda víctima.

Entonces ¿qué herramientas tenemos para transitar situaciones difíciles como estas?

La primera red de contención es el grupo de trabajo más cercano.

Cuando es posible hablar sobre estos problemas entre compañeros, con el coordinador directo o con colegas afines seguramente quienes se sienten afectados podrán resolver o canalizar su preocupación.

Un referente en cada equipo de trabajo. Para enriquecer esta red de contención, ya que para nosotros es la más importante, proponemos que cada grupo de trabajo tenga un referente que cumpla la función de contener a las segundas víctimas cuando esto sea necesario. Quienes quieran asumir este rol recibirán una capacitación especial que les brindará herramientas para actuar con más confianza.

Si estás interesado en ser referente en tu grupo de trabajo, escribinos a medicinadeltrabajo@hospitalitaliano.org.ar y nos contactaremos con vos para coordinar la capacitación.

Otras instancias de contención

Si sentís que no pudiste resolver la situación conversando con tu equipo de trabajo y necesitás de mayor orientación y acompañamiento, te brindamos otras opciones para que puedas transitar este momento con profesionales especializados en el tema:

Contacto por mail:

Comité de seguridad del paciente: seguridad.delpaciente@hiba.org.ar

Contacto telefónico:

» **Turnos mañana y tarde** (antes de las 17 h):

Servicio de Medicina del Trabajo

Lunes a Viernes de 7 a 17 h. Interno 8309.

» **Turno tarde** (luego de las 17 h.) » **turno noche** / Sa.Do.Fe:

Central de Emergencias Adultos, recepción.

** En los casos de que corresponda, se trabajará en conjunto con el servicio de Psiquiatría**

Acompañar

ESTAMOS PARA AYUDARTE

Con el fin de promover el bienestar laboral y personal de nuestra comunidad interna, fomentar un ambiente de trabajo libre de violencia y facilitar la resolución de conflictos, el Hospital Italiano creó un Programa de Asistencia Social que tiene tres grandes objetivos:



Prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, trato desconsiderado y ofensivo; y en general toda deshonra a la dignidad humana que se ejerzan sobre quienes realizan sus actividades dentro del Hospital Italiano de Buenos Aires.



Orientar, acompañar y contener a la persona que manifieste necesitar ayuda por una situación de violencia, o bien, orientación para acompañar a una tercera persona.



Asesorar y acompañar ante las dificultades personales de la comunidad interna y sus familiares convivientes.

CONFORMACIÓN DEL PROGRAMA

El programa está conformado por tres protocolos de asistencia.



Violencia laboral:

destinado a reducir, evitar y sancionar situaciones de cualquier tipo de violencia en el entorno de trabajo.



Violencia intrafamiliar y de género:

orientado a brindar contención y asesoramiento en casos de violencia física, psicológica y moral en el ámbito personal.



Gestión personal:

disponible ante dificultades personales o inquietudes en materia legal, psicológica y financiera. Destinado para todos los colaboradores y sus familiares convivientes.

METAS INTERNACIONALES

1) Identificación correcta de los pacientes

Para identificar correctamente a los pacientes, preguntar activamente:

- Nombre y apellido
- Fecha de nacimiento

Recordar verificar estos datos contra un listado o fuente.

Por situaciones especiales (neonatos, comatosos) o necesidad de desambiguar, consultar la Política 68/13 Identificación Correcta del Paciente.

2) Comunicación efectiva

Para mejorar la comunicación:

- Las indicaciones médicas deben ser escritas.
- La comunicación de resultados críticos tiene un proceso. (Ver Política N° 110/14 Comunicación Efectiva).
- Las transferencias (handover) o pases de pacientes, guardia y servicios deben quedar documentados.

3) Seguridad de los medicamentos del alto riesgo

Para mejorar la seguridad, el Hospital tiene un procedimiento para identificar y resguardar medicamentos de alto riesgo. El listado de los medicamentos de alto riesgo se encuentra en la Política 164/14 Seguridad de los Medicamentos de Alto Riesgo”.

¡RECORDAR!

No dejar recetarios de papel al alcance del público, resguardarlos siempre.

4) Cirugía: lugar, procedimiento y paciente correctos

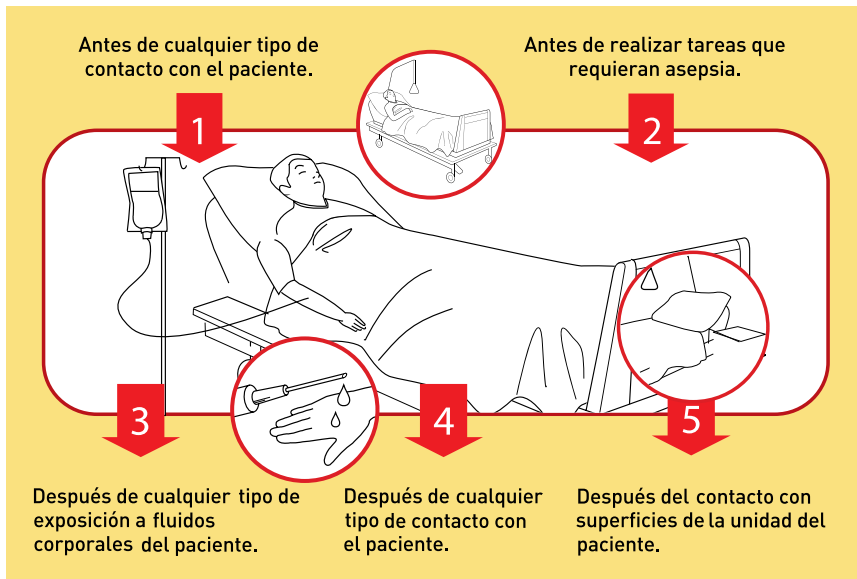
Antes de un procedimiento quirúrgico, asegurarse que el lugar, el procedimiento y el paciente sean los correctos. Recordar identificar a los pacientes que van a cirugía en todas las instancias, marcar los casos de bilateralidad, altura o multiplicidad y realizar la pausa intraoperatoria y la pausa de salida del procedimiento. Estas acciones

deben quedar documentadas. Ver Política 30/13 Cirugía en lugar correcto, con el procedimiento correcto y al paciente correcto.

5) *Riesgo de infecciones asociadas al cuidado de la salud*

La higiene de manos es la medida más sencilla y eficaz para prevenir infecciones. Consultar la Política 41/13 Higiene de Manos.

Los cinco momentos en que deberá higienizar sus manos durante un tratamiento con un paciente son:



6) *Riesgo causado por caídas*

Para reducir el daño causado por caídas en pacientes hospitalizados, es necesario valorar a los pacientes con las escalas de Morse (adultos) o HD (niños) por lo menos:

- Una vez por día.
- Cuando presenta cambios en el estado clínico o se haya modificado su medicación, como por ejemplo:

- Laxantes
 - Diuréticos
 - Psicotrópicos
 - Opiáceos
 - Sedantes
- Después de una caída.
 - Antes del alta.

Asimismo, se deberá valorar el riesgo de caída y ofrecer ayuda a cualquier persona que transite por el Hospital si es **ciega, camina con marcha zigzagueante, manifiesta dificultad para moverse y/o utiliza un medio de soporte**. En el área de consultorios ambulatorios, el personal administrativo y de seguridad colabora con la identificación del paciente con alto riesgo de caídas y el personal de enfermería realiza las acciones pertinentes para minimizar riesgos. Consultar Políticas 117/14 Riesgo de Caída en el Paciente Internado y 118/14 Riesgo de Caída en el Paciente Ambulatorio y las personas que circulan por el Hospital Italiano de Buenos Aires.

REGISTROS ASISTENCIALES

Valores/hallazgos críticos, deben ser registrados de inmediato.

- Registrá siempre en la HCE el valor comunicado y la conducta que se tomó ante el valor crítico. Consultar Norma/Política N° 110/14 Comunicación efectiva.

Apertura de la HCE completa, dentro de las 24 horas desde el ingreso

Registrá siempre:

- Motivo de internación
- Medicación habitual
- Estado de alergias
- Resultados del examen físico completo
- Evaluación de los riesgos del paciente
- Plan de cuidado completo

Evoluciones médicas, todos los días

Registrá:

- Breve resumen de internación, estado actual del paciente y aspectos pendientes
- Actualización del plan de cuidado y planificación del alta
- En internaciones prolongadas, hacé un resumen del paciente para facilitar la continuidad del cuidado.

Carta de alta

Registrá:

- Motivos de internación
- Diagnósticos realizados
- Los fármacos usados previo al ingreso y los más importantes de la internación
- La medicación a utilizar al alta
- Detalle del estado del paciente al momento del alta
- Pautas de alarma, a quién y cuándo consultar

Plan de cuidado

¿Qué es el Plan de Cuidado?

Es el conjunto de objetivos establecidos a partir de las necesidades de un paciente y es el lugar donde se planifican las acciones para el cumplimiento de dichos objetivos.

¿Qué debe incluir?

Debe ser breve e incluir objetivos medibles y acciones concretas, que puedan ser evaluadas en el día a día de la internación.

Ejemplo de Plan de Cuidado:

Paciente en posoperatorio de implante de cadera:

Problema 1: riesgo de enfermedad tromboembólica

Acción 1: Tromboprofilaxis farmacológica

Problema 2: mal manejo del dolor

Acción 2: Analgesia multimodal

¿Cuándo debe ser realizado?

- En la apertura del episodio, dentro de las primeras 24 horas del ingreso del paciente.
- Ante cambios de servicio asistencial o del estado clínico del paciente, en el módulo “Plan de Cuidado”.
- En el cierre del episodio como Plan de Cuidado al Alta (incluir objetivos y acciones a seguir posterior a la externación del paciente).

CICLOS DE LA MEDICACIÓN

Es fundamental contar con una **lista única de medicación**

• **Medicación previa a la internación**

Aclarale al paciente y a su familia que no debe consumir medicación que haya traído de su hogar. Si fuera necesario, dejá prescripto el o los fármacos que el paciente haya traído, para que la validación sea efectiva. Estos serán conservados en la Unidad de Preparación de la Medicación por Enfermería.

• **Prescripción**

Prescribí diariamente en el campo farmacológico (evitá hacerlo en “otras indicaciones”).

• **Validación**

Chequeá la validación del farmacéutico, quien puede sugerir cambios o rechazar la prescripción.

• **Administración**

Controlá el registro de la administración.

Quirófanos y Salas de Procedimientos:

Cuando realizás una prescripción de morfina, fentanilo, codeína, metadona, fenobarbital, dextropropoxifeno, ketamina, remifentanilo y tiopental, tenés que entregar la receta de la prescripción en papel.

Áreas Abiertas y Cerradas:

Debido a la pandemia, se anuló la entrega de la receta en papel. El control es a través de la prescripción médica y validación farmacéutica previa a la dispensa.

CARROS DE PARO

Recordá que es muy importante reemplazar los materiales utilizados dentro de los 30 minutos posteriores al uso del Carro de Paro.

- La reposición de estupefacientes se realiza presentando la receta manual firmada por el médico. Para más información ver Procedimiento 130/15 "Manejo de Estupefacientes y Psicotrópicos"
- La reposición de Insumos tales como gasas, pilas, jeringas, etc. se realiza a través de un pedido fuera de sistema.

¿Cuáles son los pasos para administrar medicamentos haciendo barcoding?



- El médico/a indica medicación desde la historia clínica médica.



- El farmacéutico/a valida la prescripción médica.



- A.** Verifica la indicación médica.



- B.** Obtiene la medicación.



- C.** Chequea la medicación con la lectora de códigos.



- D.** Imprime las etiquetas para cada medicamento desde la lista de preparación de medicación.



- E.** Prepara la medicación.



- F.** Accede a la sección de administración en el registro de enfermería electrónico.



- G.** Chequea la identidad del paciente escaneando el código de la pulsera con la lectora.



- H.** Escanea las etiquetas de los medicamentos a administrar con la lectora de códigos.



- I.** Administra los medicamentos por la vía correcta.



- J.** Confirma que administró la medicación.



- K.** Guarda la información consignada

El Enfermero/a:



ALERTAS TEMPRANAS

Los Scores de Alertas Tempranas sirven para detectar precozmente aquellos pacientes con potencial descompensación. Funcionan en Internación Pediátrica (PEWS), Internación General de Adultos (NEWS), Obstetricia (IMEWS) y Neonatología (NTS).

Score NEWS (Internación General Adultos):

Es fundamental tu interacción con enfermería para asegurar la eficacia del circuito de valoración y respuesta ante situaciones de alarma. Registrá en la Historia Clínica en “Indicaciones” todas las observaciones vinculadas al score.

Exclusión de pacientes de valoración

Registrá si el paciente tiene orden de no reanimar, y queda excluido del score.

Posibles interacciones en los resultados

Detallá si hay alguna situación clínica o fármaco que pueda alterar el resultado del score. En este caso, hacé junto con la enfermera la valoración del paciente.

Valoraciones

Valorá a todos los pacientes desde el ingreso y registrá los resultados en la Historia Clínica. La carga del score es la misma que la del control de los signos vitales con lo cual no duplicás tu trabajo. Luego, evaluálos con la frecuencia que te indique el resultado del score y siempre registrá la valoración.

Niveles de alarma y acciones: ejemplo para la población adulta (NEWS).

SCORE	NIVEL DE ALARMA	ACCIÓN	MONITOREO	EN TODOS LOS NIVELES DE ALARMA
0	Verde	-	Cada 8 horas	Si consideras que el score subvalora el estado del paciente, no dudes en aumentar la frecuencia del monitoreo; solicitar la intervención del médico tratante o del equipo de respuesta rápida según el caso
0-14	Amarillo	Si tenés dudas: solicitá evaluación conjunta.	Cada 4 horas	
5-7	Naranja	Solicitá de inmediato intervención del equipo de respuesta rápida. Luego, comunícale la situación al médico tratante.	Cada 1 hora	
>7	Rojo	Solicitá de inmediato intervención del equipo de respuesta rápida. Luego, comunícale la situación al médico tratante	Constante. El equipo de respuesta evaluará al paciente y si lo considera necesario, lo derivará a una unidad de mayor complejidad y será responsable de la continuidad del cuidado en la transferencia.	

FATIGA DE ALARMAS

- El hospital trabaja en la reducción del riesgo de daños asociados con las alarmas clínicas.
- Desarrolla e implementa una estrategia de reducción de riesgos:
 - existe un programa de gestión del sistema de alarmas,
 - se identifican las señales de alarma,
 - el personal está capacitado para gestionar las alarmas,
 - se definen protocolos de acción,
 - se definen responsabilidades de manejo.

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE SUICIDIO EN LA POBLACIÓN ATENDIDA

- El hospital tiene un proceso para identificar pacientes en riesgo de suicidio y autolesiones.
- Utiliza la herramienta estructurada para adultos **Sad Person**.
- Se trabaja de manera conjunta con los Servicios Asistenciales, el Servicio de Psiquiatría y Seguridad Hospitalaria.

Filtrar fichas:

- Psiquiatría
 - Sad Person**
 - Hospital de día
 - Prequirúrgico - Dolor Crónico
 - Ambulatorio - Dolor Crónico
- Valoración Adulto
 - Preingreso
 - COVID-19: SOSPECHA O DIAGNÓSTICO
 - Preingreso Mayores
 - Auditoría Plan de Salud
 - Directivas anticipadas
 - Prequirúrgico
 - Genéricas
 - Soporte nutricional
 - UTIA.1
 - UTIA.2
 - Ficha Anticoagulación
 - Obstetricia

Histórico
No existen elementos a mostrar

Escala de Indicadores de Riesgo de Suicidio
La escala de Indicadores de Riesgo de Suicidio tiene que ser heteroaplicada. Los

S ₍₁₎ : SEXO MASCULINO	☐ SI ☐ No
A: EDAD (AGE) <20 O >45 AÑOS	☐ SI ☐ No
D: DEPRESIÓN	☐ SI ☐ No
P: TENTATIVA SUICIDA PREVIA	☐ SI ☐ No
E: ABUSO DE ALCOHOL	☐ SI ☐ No
R: FALTA DE PENSAMIENTO RACIONAL (PSICOSIS O TRASTORNOS COGNITIVOS)	☐ SI ☐ No
S ₍₂₎ : CARENCIA DE APOYO SOCIAL	☐ SI ☐ No
O: PLAN ORGANIZADO DE SUICIDIO	☐ SI ☐ No
N: NO PAREJA O CÓNYUGE	☐ SI ☐ No
S ₍₃₎ : ENFERMEDAD SOMÁTICA	☐ SI ☐ No
¿HA CURSADO INTERNACIÓN EN LOS SECTORES DE OBSTETRICIA, TRAUMATOLOGÍA, DIALISIS U ONCOLOGÍA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES?	☐ SI ☐ No
PERFIL EN LETRAS	
PUNTUACIÓN	

Formulario sad person para evaluación de riesgo en adultos.

EVALUACIÓN DEL RIESGO DE SUICIDIO EN LA POBLACIÓN ATENDIDA

- Utilizó la herramienta **Evaluación Psicológica en Internación Pediátrica** en población pediátrica.
- Herramienta validada para pacientes mayores de 12 años hasta los 17 inclusive.

Fichas • Evaluación psicológica internación pediátrica

Filter fichas:

- Psiquiatría
- Kinesología
- NEWB Respuesta temprana
- Valoración Adulto
- Tramitacion
- Evaluación psicológica internación pediátrica**
- COVID-19 SUSPECHAS O DIAGNÓSTICO
- Primeros auxilios
- Auditoría Plan de Salud
- Directivas anticipadas
- Preparación
- Genética
- Soporte nutricional
- UTPA 1
- UTPA 2
- Ficha Anticoagulación

Historico

No existen elementos a mostrar

Preguntas

¿TE SIENTES DESANIMADO, DEPRIMIDO, IRRITADO O SIN ENERGÍA? ☐ Nunca ☐ Varios días ☐ Más de la mitad de los días ☐ Casi todos los días

¿TIENES POCO INTERÉS O ENCUENTRAS POCO PLACER EN HACER LAS COSAS? ☐ Nunca ☐ Varios días ☐ Más de la mitad de los días ☐ Casi todos los días

¿TIENES PROBLEMAS PARA DORMIR, MANTENERTE DORMIDO O DUEÑES SOMNOLIENTO? ☐ Nunca ☐ Varios días ☐ Más de la mitad de los días ☐ Casi todos los días

¿TIENES FALTA DE APETITO, PÉRDIDA DE PESO O COMES EN EXCESO? ☐ Nunca ☐ Varios días ☐ Más de la mitad de los días ☐ Casi todos los días

¿TE SIENTES CANSADO O CON Poca ENERGÍA? ☐ Nunca ☐ Varios días ☐ Más de la mitad de los días ☐ Casi todos los días

¿SIENTES FALTA DE AMOR PROPIO, QUE ERES UN FRACASO, O QUE TE HAS DECEPCIONADO A TI MISMO O A TU FAMILIA? ☐ Nunca ☐ Varios días ☐ Más de la mitad de los días ☐ Casi todos los días

¿TIENES DIFICULTAD PARA CONCENTRARTE EN LAS TAREAS ESCOLARES, LEER O VER LA TELEVISIÓN? ☐ Nunca ☐ Varios días ☐ Más de la mitad de los días ☐ Casi todos los días

¿TE MUEVES O HABLAS TAN LENTAMENTE QUE LA GENTE A TU ALREDEDOR LO NOTA O DE LO CONTINUO, ¿ESTÁS TAN AGITADO O IRGISTO QUE TE MUOVES MUCHO MÁS DE LO ADOPTUADO? ☐ Nunca ☐ Varios días ☐ Más de la mitad de los días ☐ Casi todos los días

¿TIENES PENSAMIENTOS DE QUE SERÍA MEJOR ESTAR MUERTO O DE QUE QUIERES HACERTE DAÑO? ☐ Nunca ☐ Varios días ☐ Más de la mitad de los días ☐ Casi todos los días

RESULTADO (*)

2da parte

EN EL ÚLTIMO AÑO, ¿TE HAS SENTIDO DEPRIMIDO O TRISTE LA MAYORÍA DE LOS DÍAS, AUN SI TE HAS SENTIDO BIEN ALGUNAS VECES? ☐ Si ☐ No

SI ESTÁS PASANDO POR CUALQUIERA DE LOS PROBLEMAS MENCIONADOS EN ESTE FORMULARIO, ¿CUÁNTA DIFICULTAD TE HAN OCASIONADO ESTOS PROBLEMAS PARA HACER TU TRABAJO, OCUPANTE DE TUS LABORES EN CASA O LLEVARTE BIEN CON LOS DEMÁS? ☐ Ninguna dificultad ☐ Alguna dificultad ☐ Mucha dificultad ☐ Extrema dificultad

Evaluación Psicológica en Internación Pediátrica.

CICLOS DE MEJORA

El ciclo de la mejora es una herramienta importante en la gestión de la calidad.

Cada ciclo requiere documentar las medidas implementadas y medir nuevamente los cambios para generar aprendizaje.

Esto se conoce como ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act)

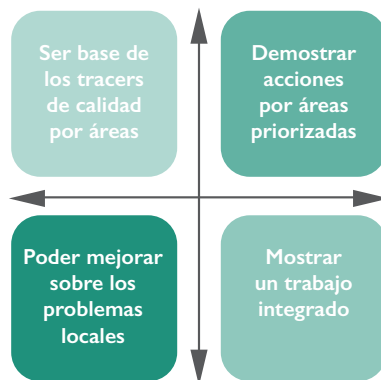
- **Planificar:** Se buscan las actividades susceptibles de mejora y se establecen los objetivos a alcanzar.
- **Hacer:** Se realizan los cambios para implantar la mejora propuesta.
- **Verificar:** Una vez implantada la mejora, se deja un período de prueba para verificar su correcto funcionamiento.
- **Actuar:** Por último, se deben estudiar los resultados y compararlos con el funcionamiento de las actividades antes de haber sido implantada la mejora.

Usted deberá poder explicar cómo se comporta un indicador en su sector. Por ej.: Los hemocultivos muestran una tasa de contaminación del 5%.

- Se *planifica* (Plan) una capacitación.
- Se *realiza* la capacitación (Do).
- Se *verifica* al mes siguiente (Check) y se encuentra que la tasa de contaminación descendió al 2%.
- Se *propone* (Act) un programa de educación continua y se entrena al personal que ingresa al Hospital.

Proformas ciclos de mejora

Objetivos:



- El hospital mide y analiza la experiencia del paciente para mejorar la calidad de la atención al paciente.
- Se valoran la calidad percibida en cuatro poblaciones:
 - Pacientes internados
 - Pacientes en Medicina Domiciliaria
 - Pacientes de Cirugías Ambulatorias
 - Pacientes de la Central de Emergencia
- Los informes de las encuestas pueden ser vistos en el sitio del Departamento de Calidad.



Realización periódica de encuestas de calidad percibida

DERECHOS

DEL PACIENTE Y SU FAMILIA



01.

Derecho a recibir la asistencia médica necesaria **sin discriminación** independientemente de su raza, sexo, nacionalidad, creencias u orientación sexual.



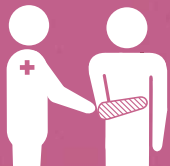
02.

Derecho a recibir asistencia **atenta y respetuosa**.



06.

Derecho a que el **dolor** sea **detectado y tratado** oportunamente.



07.

Derecho a **elegir a su** médico tratante.



11. Ante **retrasos prolongados** mayores a lo esperado para la realización de procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos, o la atención planificada, será informado sobre motivos y alternativas disponibles, así como la necesidad de inclusión en una lista de espera.



12.

Derecho a recibir **información** sobre los **medicamentos** que recibe y sus efectos adversos.



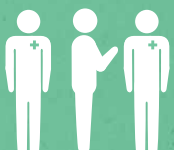
16.

Derecho a dar **directivas anticipadas**, conforme a la ley y las normas Institucionales



17.

Derecho a no recibir ningún **tratamiento experimental** sin su consentimiento.



21.

Derecho a la **confidencialidad** de su historia clínica y diagnóstico.



22.

Derecho a tener **información** sobre los **medicamentos** y sus eventos adversos.



En base a diferentes acuerdos internacionales se definieron los derechos de los pacientes en el marco del proceso asistencial. En el Hospital Italiano trabajamos día a día para que estos derechos se cumplan.

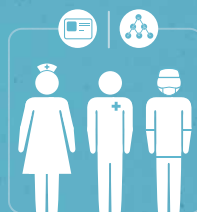
03.

Derecho a tener **privacidad** con su médico u otro profesional de la salud que lo asista.



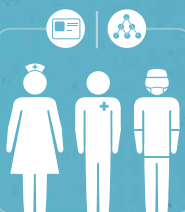
04.

Derecho a **recibir información** acerca de las reglas que afecten su asistencia en forma anticipada.



05.

Derecho a **conocer el equipo que lo asiste** y que sus miembros se presenten por su nombre, servicio y cargo.



08.

Derecho a recibir **atención religiosa** si la requiere.



09.

Derecho a ser atendido **conforme a sus pautas culturales** siempre y cuando no afecten a terceros.



10.

Derecho a **recibir información** sobre su condición, tratamiento y pronóstico, como así también sobre los efectos imprevistos de su asistencia.



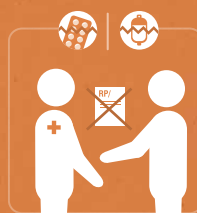
13.

Derecho a participar en la **planificación** de su plan de tratamiento.



14.

Derecho a **rehusar tratamientos** conforme a lo permitido por la ley.



15.

Derecho a **interrumpir** su tratamiento.



18.

Derecho a contar con la opción de una **segunda opinión**, sin que esto moleste al grupo tratante.



19.

Derecho a recibir toda la información necesaria acerca de la posibilidad de ser **donante de órganos** y expresar su voluntad al respecto.



20.

Derecho a acceder a su **historia clínica**, siguiendo las normativas de la Institución.



23.

Derecho a conocer en forma anticipada los **gastos** que generará su atención.



24.

Derecho a recibir una **factura detallada**.



25.

Derecho a conocer las **normas institucionales**.



PRIVACIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN

La información del paciente es información sensible y por ello debe protegerla. Mantenga la confidencialidad y privacidad de la atención e información del paciente.

¡Recordar!

- Mantener un ámbito privado durante la consulta.
- Desechar documentos que contengan información del paciente según el Procedimiento 94/12 Destrucción Controlada de Documentos que Contengan Datos Personales.
- Recordar cerrar correctamente la sesión de la HCE.
- No compartir información de pacientes en lugares públicos o con personas ajenas al grupo asistencial.
- No compartir sus contraseñas.

***Nunca** dejar a la vista listados, hojas de pases o cualquier papel con datos sensibles del paciente.*

PLANIFICACIÓN DE ALTAS

Es responsabilidad del equipo médico tratante planificar el alta y/o derivación de cada paciente **desde el momento del ingreso**, teniendo en cuenta las condiciones de salud del paciente al alta, su movilidad, sus necesidades educativas y las barreras u obstáculos que pudieran prolongar la internación innecesariamente, entre otras.

La Planificación del Alta debe documentarse en la Historia Clínica del paciente.

Para colaborar en los casos de aquellos pacientes con alta/derivación dificultosa, el Hospital cuenta con la **Unidad de Planificación del Altas (UPA)**.

SITIOS DE CONSULTA RÁPIDA ¿Dónde buscar información en Intranet?

Intranet> Comité de infecciones> 

Intranet> Secciones>Acreditación Hospitalaria

Intranet> Normas y procedimientos> 

Intranet> Bases de conocimiento>     

Intranet> Seguridad e Higiene y Protección Ambiental

Intranet>Secciones> Sistemas Informáticos> tips de HCE

Listado de normas/políticas más trascendentes para la re acreditación

Este listado te ayudará a conocer las normas/políticas más trascendentes (ya sea por su transversalidad o porque fueron los temas en los que menos rendimiento tuvo el hospital en las acreditaciones anteriores) con las cuales debes estar familiarizado a la hora de la auditoría.

Metas internacionales (IPSG)

# Política	Nombre de la Política	Propósito	¿Cuál es la actitud esperada?
68/13	Identificación correcta del paciente	Identificar correctamente a todo paciente al que se le brinda atención o tratamiento en el Hospital Italiano	Utilizar SIEMPRE los dos identificadores: • Nombre y apellido • Fecha de nacimiento En situaciones especiales revisar la política.
110/14 130/14	Comunicación efectiva	Estandarizar la comunicación entre el personal involucrado en la atención del paciente.	Asegurar la comprensión al dar o recibir información verbal entre profesionales de la salud; entre profesionales de la salud y pacientes. Documentar las transferencias (handover) entre profesionales de la salud.
164/14 173/14	Mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo	Evitar administrar erróneamente medicamentos peligrosos.	Conocer listado, segregarlos e identificarlos para evitar administraciones erróneas. Incluye precauciones en el uso de electrolitos concentrados.
30/13	Cirugía en lugar correcto, con el procedimiento correcto y al paciente correcto	Desarrollar un procedimiento estandarizado que sirva para garantizar las cirugías o procedimientos correctos, en el sitio anatómico correcto y en el paciente correcto.	Cumplir SIEMPRE con los tres pasos del check list. Realizar el marcado quirúrgico según lo descripto en la política.
41/13	Higiene de manos	Promover la higiene de manos y lograr una adherencia a la higiene de manos del 100% en toda la institución.	Higienizar las manos antes y después de cualquier contacto con el paciente o su unidad. Seguir protocolo 5 momentos OMS.
203/21	Reducción de infecciones asociadas a los cuidados de la salud	Prevención y control de infecciones asociadas a los cuidados de la salud en pacientes, personal de salud, estudiantes, familiares y/o visitas.	Cumplir con el programa de control de infecciones.
117/14 118/14	Riesgo de caídas en el paciente internado Riesgo de caída en el paciente ambulatorio y las personas que circulan por el Hospital Italiano de Buenos Aires	Reducir el riesgo de caídas de los pacientes internados, ambulatorios y visitantes y el daño ocasionado por las mismas.	Identificar a los pacientes con riesgo de caída, realizar la valoración utilizando las escalas y documentar en la Historia Clínica. Proveer consejo para la prevención de caídas. Identificar riesgos edificios.

Acceso y continuidad del cuidado (ACC)

# Política	Nombre de la Política	Propósito	¿Cuál es la actitud esperada?
65/13	Acceso y admisión.	Estandarizar el proceso y los criterios de atención y Admisión.	Cumplir con el screening de evaluación antes de internar al paciente.
66/13	Continuidad en el Cuidado del Paciente.	Establecer procedimientos que garanticen la coordinación y continuidad del cuidado del paciente.	Garantizar la continuidad en el cuidado del paciente en todas las fases de atención. El objetivo es no perder información en las interfases.
79/13	Alta, derivación y seguimiento del paciente.	Planificar y registrar el proceso de planificación y ejecución del Alta y Derivación de los pacientes.	Planificar el alta desde el ingreso. Contemplar necesidades. Registrar en la Historia clínica la planificación y ejecución del alta/ derivación de tus pacientes. Convocar a UPA en altas de riesgo.
94/14	Alta, derivación y seguimiento del paciente - Carta de Alta.	Implementar un proceso para la generación, documentación y entrega de la Carta de Alta a los pacientes.	Confeccionar y entregar carta de alta completa. Verificar comprensión. Documentar: Dirigir al paciente a la realización del Check Out.
182/15	Pacientes complejos	Identificar los grupos de pacientes que reciben atención compleja y/o con diagnóstico complejo e identificar de la información necesaria por parte de los médicos clínicos que tratan esos pacientes.	Mantener la información de estos pacientes actualizada.
80/13	Transferencia de pacientes a otra Institución	Transferir a los pacientes en forma segura.	Identificar quién recibirá al paciente, las razones de la transferencia y las necesidades especiales durante el transporte y en el destino. Documentar en HCE.
80/13	Transporte de pacientes	Identificar las necesidades de transporte, sus características, garantizar el mantenimiento y seguridad de los vehículos.	Solicitar oportunamente y detallando las características del vehículo, el transporte necesario a través de la HCE.

Cuidado centrado en el paciente (PCC)

# Política	Nombre de la Política	Propósito	¿Cuál es la actitud esperada?
73/13	Derechos y obligaciones del paciente y su familia	Proteger el libre ejercicio de los derechos por parte del paciente y su familia durante todo el proceso de atención.	Conocer y respetar los derechos y obligaciones del paciente y su familia.
34/13	Privacidad y confidencialidad del cuidado y la información	Velar por la privacidad del paciente y su información durante todas las instancias del cuidado.	Garantizar privacidad de los paciente (relacionados con pudor; ámbitos de entrevistas resguardados) y mantener la confidencialidad de la información clínica. Comentar datos clínicos en ámbitos reservados. Resguardar papeles con información de pacientes. Cerrar sesiones de HCE.
45/13	Derechos a la participación en la atención	Que los pacientes y sus familiares participen en el proceso de atención tomando decisiones, haciendo preguntas e incluso rechazando procedimientos de diagnóstico y tratamientos.	Involucrar al paciente y su familia en el proceso de atención, sin tomar represalias ante negativas. Facilitar segunda opinión si lo solicita.
4/13	Orden de no reanimar	Evitar maniobras innecesarias.	Identificar pacientes con esta condición. Consignar ONR O LET en las indicaciones médicas. Involucrar a la familia y equipo de salud.
202/20	Análisis de la Calidad de Atención percibida por el Paciente	Analizar la experiencia del paciente	Consultar el sitio del Departamento de Calidad: https://www.hospitalitaliano.org.ar/#/home/calidad/inicio
56/13	Derechos y responsabilidades relacionados con la suspensión o rechazo a un tratamiento	Que los pacientes y sus familiares conozcan los derechos y responsabilidades por la suspensión y/o rechazo a un tratamiento.	Informar al paciente y su familia acerca de su derecho a rechazar o suspender su tratamiento. Considerar aspectos culturales y religiosos que afectan las decisiones. Garantizar sus cuidados a pesar de negativas. Contactar al Comité de Ética ante dudas.
74/13	Obtención del Consentimiento Informado	Garantizar el derecho del paciente a participar en la toma de decisiones durante su cuidado y proveer educación. Velar por los derechos.	Asegurar y documentar la comprensión del procedimiento y/o tratamiento al paciente (riesgos, beneficios, alternativas, consecuencias de la no realización). Utilizar el generador de consentimientos de la HCE. Se debe registrar la fecha y hora en la que el paciente firma el Consentimiento Informado.

Evaluación de los pacientes (AOP)

# Política	Nombre de la Política	Propósito	¿Cuál es la actitud esperada?
136/14	Evaluación inicial de pacientes	Definir el contenido mínimo de la evaluación inicial (internados y ambulatorios).	Generar evaluaciones iniciales completas y oportunas.
137/14	Contenido de la evaluación inicial, factores físicos, psicológicos y socioeconómicos	Definir el contenido mínimo de la evaluación inicial.	Tener en cuenta los aspectos físicos, psicológicos y socioeconómicos. Documentarlos en la evaluación inicial (internados y ambulatorios).
16/13	Programa de seguridad en imágenes diagnósticas y/o terapéuticas	Programa de seguridad radiológica que incluya: Leyes y normativas, Identificación de Factores de Riesgo, Gestión de las instalaciones, Programa de irradiación, Entrenamiento.	Cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos establecidos.

Atención de los pacientes (COP)

# Política	Nombre de la Política	Propósito	¿Cuál es la actitud esperada?
8/13 47/13 7/13 6/13 21/13 40/13 152/14 126/14 114/14 116/14 113/14 122/14 123/14	Atención del paciente de alto riesgo	Identificar y estandarizar el cuidado de los pacientes de alto riesgo.	Son pacientes de alto riesgo: diálisis, quimioterapia EV, sujetos, emergencia, comatosos, son soporte vital, infectocontagiosos, inmunocomprometidos, vulnerables (niños, mayores, dependientes, los que no pueden tomar decisiones). Requisitos para cada población: identificarlos, contemplar tecnología, consentimiento, interconsulta, monitoreo, calificaciones del personal cuando corresponda.
39/13	Reanimación	Proveer servicios efectivos de reanimación cardiopulmonar.	Conocer maniobras, activación de alarmas, internos y radios. Entrenamiento del personal. Uso de DEAS.
22/13	Medicina Transfusional	Establecer pautas para almacenamiento de sangre, solicitud, administración y monitoreo de transfusiones.	Solicitar transfusiones de modo estandarizado. Cumplir con el monitoreo durante y post transfusión.
19/13	Dolor	Establecer escalas para la valoración del dolor; documentarlo y tratarlo.	Identificar pacientes con dolor según escala correspondiente.
149/14	Final de vida	Adecuar los cuidados del paciente con enfermedad terminal y/o situación de agonía.	Abordar adecuadamente las necesidades físicas, psicoemocionales, sociales, espirituales y culturales de la Unidad de tratamiento, incluyendo lo relativo al fallecimiento y el duelo.

Anestesia y atención quirúrgica (ASC)

# Política	Nombre de la Política	Propósito	¿Cuál es la actitud esperada?
38/13	Guías de Práctica Profesional para la Sedación / CAM durante procedimientos y su Monitoreo		La administración de sedación/ CAM es realizada por profesionales no involucrados en el procedimiento diagnóstico ni terapéutico y están correctamente certificados y entrenados para proporcionar monitorización ininterrumpida de los parámetros fisiológicos del paciente y asistencia en medidas de apoyo y reanimación. En todos los casos completar la ficha de Sedación en la HCE.
180/15	Monitoreo y registro del estado fisiológico del paciente posterior a la anestesia	Obtener Scores de recuperación que permitan espaciar su control y derivar en el alta de los pacientes hacia los sectores correspondientes y/o alta hospitalaria si así lo requiriera la circunstancia de práctica realizada.	Registrar los signos vitales en el minuto 0 (cuando el paciente ingresa a la UCPPA o área correspondiente) y luego cada 15 minutos durante la primera media hora. Pasada ésta, el registro es por hora hasta que el paciente sea dado de alta de la UCPPA. En caso de que el paciente cumpla con el score de alta correspondiente (PADSS para pacientes ambulatorios o White y Song para pacientes internados) antes de la media hora, se registra el control de signos vitales a los 0-15 minutos y al alta de la UCPPA.

Manejo y uso de medicamentos (MMU)

# Política	Nombre de la Política	Propósito	¿Cuál es la actitud esperada?
172/14	Reconciliación de medicamentos	Contribuir a prevenir errores relacionados con medicamentos mediante la implementación de instancias formales para la reconciliación medicamentosa, que permitan, a cada paciente, contar con un listado único de medicamentos que esté documentado en su historia clínica y sea actualizado por lo menos en las instancias donde pueda sufrir mayores cambios.	Ver el Listado de Listado de Medicación y sus Recomendaciones Institucionales pre procedimientos invasivos (publicado en intranet GPC). Realizar la reconciliación medicamentosa de los pacientes en las siguientes instancias: • Apertura de episodio de internación. • Alta de internación. • Pase de internación general a unidad de cuidados intermedios o críticos. • Pase de unidades de cuidados intermedios o críticos a internación general. • Ante todo contacto en consultorio.
162/14	Prescripción, pedido y transcripción de medicamentos	Evitar errores relacionados con la prescripción de medicamentos.	Utilizar prescripción electrónica (pacientes internados y ambulatorios). De necesitar receta en papel: garantizar legibilidad y completitud (letra imprenta mayúscula).
170/14	Validación de las prescripciones y pedidos de medicamentos	Proceso de validación por parte de farmacia.	Responder a las inquietudes del farmacéutico si consulta por recetas detenidas.
131/14	Pacientes internados autorizados a traer su medicación	Estandarizar el proceso para el almacenamiento y uso de medicamentos traídos por el paciente.	Cumplir el procedimiento publicado en Normas y Procedimientos. Prescribir para posibilitar validación aclarando "lo trae el paciente". Enfermería documenta recepción de medicamentos con nombre y número de lote, dosis y vencimiento, y devuelve al alta. Almacena segregado garantizando las mismas condiciones que para el resto de los medicamentos. El Hospital no autoriza la auto administración de medicamentos.
111/14	Muestras médicas de medicamentos	Garantizar la seguridad de los medicamentos (muestras médicas).	Sólo administrar muestras médicas cumpliendo con el procedimiento publicado en Normas y Procedimientos. Enviar a farmacia muestras médicas encontradas fuera de este circuito. Recordar que el recall y condiciones de almacenamiento aplican a muestras médicas.
42/13	Monitoreo de los efectos de la medicación	Reducir la frecuencia de los eventos adversos asociados al uso de la medicación. Trabajar en ciclos de mejora a partir de los eventos adversos detectados.	Monitorizar los efectos de la medicación y reportar los eventos adversos que detectes a través del Reporte de Incidentes.
71/13	Monitoreo de los errores y casi errores de medicación	Monitorear los errores asociados al manejo de la medicación. Monitorear los casi-errores asociados al manejo de la medicación.	Reportar los errores que detectes a través del Reporte de Incidentes.

Mejora de la calidad y seguridad de los pacientes (QPS)

# Política	Nombre de la Política	Propósito	¿Cuál es la actitud esperada?
57/13	Objetivos del Programa de Calidad	El gobierno del hospital asegura la mejora continua en la calidad y seguridad a través de una correcta implementación de un programa.	Conocer el programa de calidad del hospital. Consultar en http://www.hospitalitaliano.org.ar/calidad/index.php
200/20	Evento adverso sin daño Y Casi-Error	Definir la sistemática empleada en el Hospital Italiano de Buenos Aires para el análisis de los eventos adversos sin daño y los cuasi-errores.	Reportar los eventos adversos sin daño y casi-errores que detectes a través del Reporte de Incidentes.

Prevención y control de infecciones (PCI)

# Política	Nombre de la Política	Propósito	¿Cuál es la actitud esperada?
35/13	Programa de Reducción de riesgos de Infecciones	Prevención y control de infecciones asociadas a los cuidados de salud.	Consultar el sitio del Comité de Control de Infecciones: http://www.hospitalitaliano.org.ar/infecciones/
195/17	Plan de contingencia para enfermedades transmisibles de impacto global	Detección precoz de casos y establecer medidas de protección	Consultar el sitio del Comité de Control de Infecciones: http://www.hospitalitaliano.org.ar/infecciones/
55/14	Inducción y capacitación en prevención y control de infecciones	Brindar conocimientos básicos en prevención de Infecciones Asociadas a los Cuidados de Salud (IACS).	Consultar el sitio del Comité de Control de Infecciones: http://www.hospitalitaliano.org.ar/infecciones/

Administración y seguridad de las instalaciones (FMS)

# Política	Nombre de la Política	Propósito	¿Cuál es la actitud esperada?
67/13	Evaluación y monitoreo de riesgos	Establecer y mantener una serie de planes que abarquen los riesgos dentro de las áreas de seguridad, materiales peligrosos, emergencias, seguridad ante incendios, equipamiento médico y sistemas de suministros básicos.	Cumplir con las recomendaciones para colaborar con un ambiente seguro y protegido.
139/14	Seguridad Física	Establecer e implementar diferentes planes y programas para propiciar un ambiente seguro para pacientes, familiares, colaboradores y visitantes.	Cumplir con las recomendaciones para colaborar con un ambiente seguro y protegido.
184/15	Residuos Peligrosos	Constituir un programa que establezca los lineamientos necesarios para el control de los residuos de los materiales peligrosos.	Segregar los residuos de forma adecuada. Consultar con Seguridad e Higiene y Protección Ambiental ante cualquier duda.
89/13	Emergencia por Fuego, Humo y otras	Constituir un programa que establezca la prevención, detección temprana, supresión, respuesta y evacuación segura de la instalación en caso de incendio u otra emergencia que lo requiera y el ensayo regular del programa.	Conocer el plan de evacuación de tu sector. Visitar el sitio de Intranet de Seguridad e Higiene y Protección Ambiental.
29/13	Programa Antitabaco y Designación de Espacios para Fumar	Contribuir a la salud de las personas. Contribuir en la prevención de incendios.	No fumar dentro de las instalaciones del hospital.
88/13	Manejo de Desastres de origen interno y externo	Desarrollar planes de acción para la prevención y actuación ante Emergencias, Alertas Sanitarias, Desastres o Catástrofes de origen interno o externo.	Conocer las responsabilidades y acciones ante una situación de emergencia, alerta sanitaria, desastre o catástrofe.

Cualificación y educación del personal (SQE)

# Política	Nombre de la Política	Propósito	¿Cuál es la actitud esperada?
60/13	Descripción de puestos de trabajo	Crear un marco de acuerdo de acciones y resultados entre el Empleado y el Empleador.	Conocer la descripción de tu puesto y el alcance de tus responsabilidades.
84/13	Seguridad y Salud Ocupacional	Identificar, prevenir, controlar y reducir los riesgos de accidentes y enfermedades ocupacionales.	Seguir las recomendaciones de Seguridad y Protección vinculadas a tu tarea.
198/17	Segundas Víctimas	Asegurar una respuesta adecuada y proporcional ante la ocurrencia de un evento adverso a fin de mitigar las consecuencias emocionales del mismo en el/los profesional/es involucrado/s.	Conocer el proceso de contención establecido para los colaboradores asistenciales afectados como segunda víctima ante un evento adverso. Ante cualquier consulta comunicarse con seguridad.delpaciente@hiba.org.ar o Medicina del Trabajo.
64/13	Privilegios Médicos	Determinar privilegios médicos.	Consultar en Intranet>Personal tu ficha de Privilegios (solo para médicos).
43/13	Asignación de privilegios al Staff Médico	Definir los procedimientos autorizados/médico.	Consultar en Intranet>Personal tu ficha de Privilegios (solo para médicos).
63/13	Proceso de seguimiento y evaluación de profesionales	Emplear un proceso estandarizado y continuo para evaluar la calidad y la seguridad de la atención a pacientes que brinda cada miembro del staff médico.	Cumplir con la realización de evaluaciones de desempeño en tiempo y forma.

Gestión de la información (MOI)

# Política	Nombre de la Política	Propósito	¿Cuál es la actitud esperada?
48/13	Protección de la Información	Velar por que los registros y la información de la organización sean preservados de pérdida, divulgación o alteración no autorizados	Cuidar la información clínica y el acceso a la misma: no prestes ni divulgues tu clave.
92/13	Historia Clínica Estandarizada	Describir el contenido requerido de la Historia Clínica del paciente desde el inicio (empadronamiento) a lo largo de todo el proceso a fin de mantener un registro preciso, actualizado y completo para todos los pacientes que reciben atención y cuidado en el Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA).	Completar todos los registros clínicos en tiempo y forma, de manera homogénea y sin abreviaturas. Una Historia Clínica completa contribuye al mejor cuidado del paciente.
72/13	Acceso autorizado a la Historia Clínica del Paciente	Identificar a aquellas personas autorizadas a ingresar a la Historia Clínica del paciente. Identificar situaciones en las que se permite el acceso electrónico a los registros asistenciales y en las que no está permitido. Resumirlas consecuencias para el acceso inapropiado (no autorizado) a la información médica del paciente.	NO PRESTAR LA CLAVE. Completar todos los campos que el sistema pide para justificar tu ingreso.

Departamento de Calidad

Interno 9947 ó 4506

Hospital Italiano de Buenos Aires

Tte. Gral. J. D. Perón 4190
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel. (011) 4959-0200
www.hospitalitaliano.org.ar